

Efecto de la psilocibina en los síntomas depresivos y de ansiedad en adultos en edad laboral: una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados

Miguel Ángel Trejo-Rodríguez, Erik González-Ballesteros, Sandra Martínez-Robles, Andrea Estefanía Aranda Rosas, Leandro Jesús Lozano García

TÍTULO DE LA REVISIÓN Y DETALLES BÁSICOS

Título de la reseña

Efecto de la psilocibina en los síntomas depresivos y de ansiedad en adultos en edad laboral: una revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados

Tipo de reseña

No hay vista previa disponible

Condición o dominio que se está estudiando

Trastorno depresivo mayor; Trastorno de ansiedad; Ansiedad

Trastornos depresivos primarios (incluyendo trastorno depresivo mayor y depresión resistente al tratamiento) y trastornos de ansiedad primarios (incluyendo trastorno de ansiedad generalizada) en adultos en edad laboral (18 a 65 años). La depresión o ansiedad secundaria a enfermedades somáticas graves o terminales (como cáncer, enfermedad de Parkinson o demencia) está fuera del ámbito de esta revisión, al igual que las condiciones estudiadas sin resultados de depresión o ansiedad reportados por separado (como el trastorno por consumo de alcohol o trastornos alimentarios).

Justificación de la reseña

La psilocibina ha pasado rápidamente de la exploración en fases tempranas a ensayos controlados aleatorizados de fase 2 y 3 para trastornos depresivos y de ansiedad, incluyendo ensayos pioneros de dosis única en depresión resistente al tratamiento. Las revisiones sistemáticas y metaanálisis existentes agrupan principalmente ensayos realizados antes de esta reciente expansión, combinan poblaciones heterogéneas (incluidos pacientes con enfermedades somáticas potencialmente mortales y angustia existencial) y mezclan psilocibina con otros compuestos psicodélicos, lo que limita la interpretabilidad clínica de estimaciones agrupadas para pacientes con trastornos depresivos o de ansiedad primaria. Esta revisión aborda estas limitaciones restringiendo la elegibilidad a ensayos controlados aleatorizados publicados entre 2022 y 2026 en adultos en edad laboral (de 18 a 65 años) con trastornos depresivos y/o de ansiedad primarios, excluyendo la depresión o ansiedad secundaria a una enfermedad somática grave. Los análisis de moderadores preespecificados (régimen de dosis, presencia de psicoterapia asistida, población diagnóstica, tipo de comparador) y análisis de sensibilidad (riesgo de sesgo, estado de preprint) examinarán las fuentes de heterogeneidad. La revisión proporcionará una estimación actualizada y específica por población de la eficacia y seguridad de la psilocibina, con certeza de la evidencia valorada mediante GRADE, para informar la investigación clínica y el debate regulatorio durante un periodo de actividad acelerada de los ensayos.

Objetivos de la revisión

Pregunta principal: En adultos de 18 a 65 años con trastorno depresivo primario y/o de ansiedad, ¿mejora el tratamiento con psilocibina, en comparación con placebo o tratamientos habituales o activos, la gravedad de los síntomas depresivos medidos en escalas validadas?

Preguntas secundarias: (1) ¿Mejora la psilocibina la gravedad, la respuesta, la remisión, el funcionamiento y la calidad de vida de los síntomas de ansiedad en comparación con los mismos comparadores? (2) ¿Cuál es la frecuencia y el perfil de los eventos adversos asociados a la psilocibina en esta población? (3) ¿Varían los efectos del tratamiento según el régimen de dosis, la presencia de psicoterapia asistida, la población diagnóstica (trastorno depresivo frente a trastorno de ansiedad) o el tipo de comparador? (4) ¿Son las estimaciones agrupadas robustas excluyendo a los ensayos con alto riesgo de sesgo y de preprints?

Palabras clave

Psilocibina; Terapia asistida con psicodélicos; Trastorno depresivo mayor; Depresión resistente al tratamiento; Trastorno de ansiedad generalizada; Ensayos controlados aleatorizados; Metaanálisis

País

México

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Población

Incluido

Adultos de 18 a 65 años (en edad laboral) con diagnóstico principal de trastorno depresivo (incluyendo trastorno depresivo mayor y depresión resistente al tratamiento) y/o trastorno de ansiedad (incluyendo trastorno de ansiedad generalizada), establecido mediante criterios diagnósticos reconocidos (por ejemplo, DSM-5 o CIE-10/11) o una entrevista estructurada validada. Los participantes mantienen su rutina diaria y funcionamiento ocupacional, sin necesidad de cuidados paliativos. Los ensayos que inscriban poblaciones diagnósticas mixtas son elegibles si los resultados para los participantes elegibles se informan por separado o constituyen la clara mayoría de la muestra.

Excluidos

Participantes menores de 18 o mayores de 65 años. Depresión o ansiedad secundaria o explícitamente reactiva a enfermedades somáticas graves o terminales (incluyendo cáncer, enfermedad de Parkinson, demencia u otras condiciones graves con implicaciones conductuales). Ensayos que inscribieron participantes principalmente por otras condiciones (incluyendo trastorno por consumo de alcohol, otros trastornos por consumo de sustancias o trastornos alimentarios) sin resultados de depresión o ansiedad reportados por separado. Voluntarios sanos. Pacientes que reciben cuidados paliativos o al final de la vida.

Intervención(es) o exposición(es)

Incluido

Psicoterapia; Psilocibina

La psilocibina se administra por vía oral como intervención principal, en dosis individuales o múltiples bajo un régimen de dosificación definido, a cualquier nivel de dosis, con o sin apoyo psicológico o psicoterapia asistida. Son elegibles tanto las formulaciones sintéticas de psilocibina (por ejemplo, COMP360) como las estandarizadas. La administración debe realizarse en un entorno clínico o de investigación supervisado. La presencia y el tipo de apoyo psicológico serán registrados y examinados como un moderador predefinido.

Excluidos

Intervenciones que combinan psilocibina con otros compuestos psicodélicos o serotoninérgicos administrados como parte del mismo protocolo (incluyendo ayahuasca, MDMA, LSD, DMT o ketamina), donde el efecto de la

psilocibina no puede aislarse. Regímenes de microdosificación sin un protocolo supervisado definido. Preparaciones de setas enteras o no estandarizadas sin contenido definido de psilocibina. Uso recreativo, naturalista o no supervisado.

Comparador(es) o control(es)

Incluido

Etiquetas PICO seleccionadas: Placebo; Cuidado habitual; Antidepresivos; Control de listas de espera

Control placebo o similar al placebo (incluyendo niacina o psilocibina de dosis muy bajas utilizada como placebo activo), tratamiento habitual (incluyendo antidepresivos aprobados como el escitalopram), lista de espera o comparadores farmacológicos o psicoterapéuticos activos. Cuando un ensayo incluye varios brazos comparadores elegibles, el análisis principal utilizará el comparador menos activo; El tipo de comparador será examinado como un moderador predefinido.

Excluidos

Brazos comparadores que consisten en otros psicodélicos clásicos en dosis psicoactivas (por ejemplo, LSD, ayahuasca, DMT) o ketamina o esketamina, ya que estas comparaciones abordan la eficacia relativa de los psicodélicos más que el efecto de la psilocibina frente al cuidado estándar.

Diseño del estudio

Solo se incluirán los tipos de estudios aleatorizados.

Incluido

Los ensayos controlados aleatorizados, incluyendo ensayos de fase 2, 3 y fase 4, con diseños de grupos paralelos o cruzados (los ensayos cruzados aportarán datos del primer periodo donde la transferencia sea plausible dado los efectos persistentes de la psilocibina). Los ensayos deben informar de gravedad de depresión y/o ansiedad en escalas validadas (por ejemplo, MADRS, HAM-D, PHQ-9, BDI, HAM-A, GAD-7, STAI, BAI). Las publicaciones revisadas por pares y los preprints en revisión (recuperados a través de Europe PMC, incluyendo medRxiv) publicados entre 2022 y 2026 son elegibles; Los preprints que lleguen a la publicación en revistas antes de la extracción de datos serán reemplazados por la versión revisada por pares. Sin restricciones de idioma.

Excluidos

Ensayos de fase 1 en participantes sanos; estudios no aleatorizados, estudios observacionales, informes de casos y series de casos; revisiones sistemáticas y metaanálisis; estudios en animales e in vitro; resúmenes de conferencias sin datos suficientes de resultados; informes cuyo texto completo no puede ser recuperado tras el acceso institucional y el contacto con los autores (documentados como informes no recuperados en el diagrama de flujo PRISMA).

Contexto

Los ensayos realizados en cualquier entorno clínico o de investigación (unidades hospitalarias, ambulatorias o de investigación dedicadas) y en cualquier país serán elegibles; No se aplican restricciones geográficas ni de nivel de ingresos. La psilocibina debe administrarse en un contexto clínico o de investigación supervisado bajo un protocolo de dosificación definido; Se excluyen estudios sobre uso recreativo, naturalista o no supervisado. Los ensayos publicados desde el 1 de enero de 2022 hasta la fecha final de búsqueda en 2026 son elegibles; Esta ventana corresponde a la reciente expansión de la actividad de los ensayos de fase 2 y fase 3. No se aplican restricciones de idioma.

RESEÑAS SIMILARES

Consulta registros similares ya en PROSPERO

PROSPERO identificó varios registros existentes de PROSPERO que eran similares a este (última verificación realizada el 11 de agosto de 2026). A continuación se muestran junto con las razones dadas por el equipo de revisión para que las revisiones sean diferentes y/o en curso.

- Aplicaciones terapéuticas de la psilocibina para la depresión primaria y secundaria: una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorizados [publicado el 8 de mayo de 2026] [CRD420261391152]. Se reconoció que la revisión era **similar**, pero los autores optaron por continuar porque *existen diferencias en la población, la revisión analiza resultados adicionales o diferentes, la revisión estará más actualizada y utiliza métodos mejorados*. Los autores también señalaron: "Esta revisión comparte la psilocibina como intervención, la elegibilidad solo para ECA y el trastorno depresivo mayor primario en adultos como una de las poblaciones objetivo. Nuestra reseña difiere en cuatro aspectos sustantivos. En primer lugar, el objetivo central de esa revisión es la comparación entre la depresión primaria y la depresión secundaria a enfermedades potencialmente mortales; Nuestra revisión excluye por completo la depresión secundaria y se limita a diagnósticos primarios en adultos en edad laboral (de 18 a 65 años). En segundo lugar, nuestra revisión incluye los trastornos de ansiedad primarios como población coprimaria, que esa revisión no aborda. En tercer lugar, nuestra revisión está restringida a ensayos publicados entre 2022 y 2026 e incorpora preprints a través de una fuente complementaria predefinida (Europa PMC/medRxiv), dirigida a la reciente expansión de fase 2/3. Cuarto, nuestra revisión realiza un metaanálisis cuantitativo con moderadores predefinidos (régimen de dosis, psicoterapia asistida, población diagnóstica, tipo de comparador), análisis de sensibilidad y calificación GRADE, mientras que ese registro describe una revisión sistemática sin síntesis metaanalítica. Procederemos."
- Psilocibina para trastornos depresivos: revisión sistemática y metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados [publicado el 5 de abril de 2026] [CRD420261361083]. La revisión fue reconocida como **similar**, pero los autores optaron por continuar porque *existen diferencias en la población, la revisión analiza resultados adicionales o diferentes y estará más actualizada*. Los autores también señalaron: "Este registro es el más cercano al nuestro: comparte psilocibina como intervención, elegibilidad solo para ECA y una síntesis metaanalítica de efectos aleatorios. Nuestra revisión difiere más en alcance que en rigor. Primero, población: esa revisión se restringe al trastorno depresivo mayor y a la depresión resistente al tratamiento, mientras que la nuestra además incluye los trastornos de ansiedad primarios como población coprimaria, restringe la elegibilidad a adultos en edad laboral (de 18 a 65 años) y excluye explícitamente la depresión o ansiedad secundarias a una enfermedad somática grave. Segundo, resultados: metaanalizaremos la gravedad de los síntomas de ansiedad en escalas validadas, junto con la respuesta, remisión, funcionamiento y calidad de vida; Esa revisión aborda los resultados negativos, la durabilidad y señales específicas de seguridad. Tercero, moneda y fuentes: nuestra búsqueda se realizará tras la aprobación del registro con un corte posterior, restringido a la ventana de expansión de la prueba 2022-2026, e incorporando preprints a través de una fuente complementaria preespecificada (Europa PMC/medRxiv). Además, preespecificamos la psicoterapia asistida como moderador y valoraremos la certeza de la evidencia con GRADE. Las reseñas son complementarias; Procederemos."
- Mediadores terapéuticos y subjetivos del tratamiento con psilocibina para la ansiedad y la depresión: una revisión sistemática y metaanálisis [publicado el 19 de enero de 2026] [CRD420251171691]. La revisión fue reconocida como **similar**, pero los autores optaron por continuar porque *existen diferencias en la población, la revisión analiza resultados adicionales o diferentes y estará más actualizada*. Los autores también señalaron: "aunque su título enfatiza los mediadores, el objetivo principal de este registro coincide con el nuestro: efectos terapéuticos de la psilocibina en la ansiedad y la depresión en adultos medidos en escalas validadas. Nuestra reseña difiere en tres aspectos. Primero, población: nuestra elegibilidad está restringida a adultos en edad laboral (de 18 a 65 años) con trastornos depresivos primarios y/o de ansiedad, excluyendo explícitamente la ansiedad o depresión secundarias a enfermedades somáticas potencialmente mortales, una población que las síntesis centradas en

mediadores suelen incluir mediante ensayos en angustia existencial. Segundo, resultados y enfoque analítico: la contribución distintiva de esa revisión es la síntesis de medidas subjetivas-experienciales (MEQ-30, 5D-ASC, Inventario de Avances Emocionales) como mediadores de la mejora, que no abordamos; nuestra revisión en su lugar sintetiza la respuesta, remisión, funcionamiento, calidad de vida y eventos adversos, con moderadores predefinidos (régimen de dosis, psicoterapia asistida, población diagnóstica, tipo de comparador) y la calificación de certeza GRADE. Tercero, la moneda: nuestra búsqueda se realizará tras la aprobación del registro, restringida a la ventana de expansión de la prueba 2022-2026, e incorpora preprints a través de una fuente complementaria preespecificada. Las preguntas mecanicistas y de estimación de efectos son complementarias; Procederemos."

CRONOLOGÍA DE LA RESEÑA

Fecha de la primera presentación a PROSPERO

Este registro no ha sido presentado.

Cronología de la revisión

Fecha de inicio de la reseña: 12 de agosto de 2026. Fecha de finalización de la reseña: 31 de marzo de 2027.

Fecha de registro en PROSPERO

Este registro no ha sido publicado.

DISPONIBILIDAD DEL PROTOCOLO COMPLETO

Disponibilidad del protocolo completo

Se ha escrito y subido un protocolo completo a PROSPERO. El protocolo puede accederse a través de este [enlace https://www.crd.york.ac.uk/PROSPEROFILES/3ef4c818d6d1a23188671dd1de96d182.pdf](https://www.crd.york.ac.uk/PROSPEROFILES/3ef4c818d6d1a23188671dd1de96d182.pdf).

BÚSQUEDA Y SELECCIÓN

Búsqueda de estudios no publicados

Se buscarán tanto estudios publicados como no publicados.

Principales fuentes que se buscarán

Las principales fuentes a buscar son *CENTRAL - Registro Central de Ensayos Controlados Cochrane* y *PubMed*.

Otras fuentes que se buscarán

Europe PMC (filtro de preimpresión SRC:PPR, que indexa medRxiv) como fuente complementaria preespecificada para preprints en revisión; Búsqueda de citas hacia atrás de ensayos incluidos y revisiones sistemáticas recientes. Los registros de ensayos clínicos están cubiertos indirectamente a través de CENTRAL, que incorpora los registros de ClinicalTrials.gov y ICTRP de la OMS.

Restricciones en el idioma de búsqueda

No hay restricciones de idioma.

Restricciones de fecha de búsqueda

Se buscarán en las bases de datos artículos publicados a partir del 1 de enero de 2022, no hay restricciones en la fecha de finalización de la búsqueda.

Otros métodos para identificar estudios

Otros estudios se identificarán mediante: *contactar con autores o expertos, comprobar listas de referencias (búsqueda de citas hacia atrás) y buscar en registros de ensayos o estudios.*

Información adicional sobre la identificación de estudios

Los registros de ensayos clínicos están cubiertos por CENTRAL, que incorpora registros ICTRP de ClinicalTrials.gov y de la OMS. Los preprints se recuperan a través de Europe PMC (FILTRO SRC:PPR, indexación medRxiv). Se contactará con los autores por textos completos no recuperables y por datos de resultados ausentes.

Enlace a la estrategia de búsqueda

Una estrategia de búsqueda completa está disponible en el protocolo completo, tal como se describe en la sección *Disponibilidad del protocolo completo*

Proceso de selección

Los estudios serán evaluados de forma independiente por al menos dos personas (o combinación persona/máquina) mediante un proceso para resolver diferencias.

Otra información relevante sobre búsquedas y cribado

Todas las búsquedas se ejecutarán el mismo día y se documentarán completamente siguiendo PRISMA-S, registro de la base de datos, interfaz, fecha de búsqueda y número de registros recuperados. Los registros se deduplicarán en Rayyan o Zotero antes de la proyección, emparejados por DOI y por título normalizado. Dos revisores completarán un ejercicio de calibración sobre una muestra piloto de registros antes de que comience el cribado formal, con criterios de elegibilidad refinados para mayor claridad (pero no para el alcance) si es necesario. Se documentarán y reportarán las decisiones de selección y los motivos de la exclusión del texto completo. Los preprints identificados a través del PMC europeo se verificarán en la extracción de datos de las bases de datos de revistas; cualquier prepublicación que haya llegado a una publicación revisada por pares será reemplazada por la versión publicada, y la sustitución será documentada. Los artículos retractados serán excluidos en cualquier etapa, con verificación contra la base de datos de Retraction Watch para todos los ensayos incluidos antes del análisis.

PROCESO DE RECOPIACIÓN DE DATOS

Extracción de datos de artículos e informes publicados

Los datos serán extraídos de forma independiente por al menos dos personas (o combinación persona/máquina) con un proceso para resolver diferencias.

No se contactará con los autores para obtener más información.

Riesgo de sesgo en el estudio o evaluación de la calidad

Los datos serán evaluados de forma independiente por al menos dos personas (o combinación persona/máquina) mediante un proceso para resolver diferencias.

Se solicitará información adicional a los investigadores del estudio si la información requerida no está clara o no está disponible en las publicaciones o informes del estudio.

Evaluación del sesgo de reporte

Diagramas de embudo mejorados por contornos de nivel y prueba de Egger ($k \geq 10$ por resultado); comparación de resultados reportados frente a entradas en el registro de ensayos y protocolos publicados para detectar la no notificación selectiva; mitigación a nivel de búsqueda mediante preprints, registros de ensayos y sin restricciones de idioma; el sesgo de publicación se calificó como dominio GRADE según el resultado.

Evaluación de la certeza

La certeza de la evidencia se valorará por resultado utilizando el enfoque GRADE, teniendo en cuenta el riesgo de sesgo, inconsistencia, indirectidad, imprecisión y sesgo de publicación. Dos revisores aplicarán GRADE de forma independiente, y los desacuerdos se resolverán por consenso. Los resultados se presentarán en una tabla de Resumen de Hallazgos generada con GRADEpro GDT, que informará de los efectos absolutos y relativos con calificaciones de certeza y justificaciones en notas al pie para cada decisión de rebaja. La certeza se valorará por separado para el resultado principal (gravedad de los síntomas depresivos) y para cada desenlace secundario (gravedad de los síntomas de ansiedad, respuesta, remisión, funcionamiento, calidad de vida, eventos adversos).

RESULTADOS A ANALIZAR

Principales resultados

Resultado principal: cambio respecto al punto base en la gravedad de los síntomas depresivos, medido en escalas validadas de evaluación o autoinforme (MADRS, HAM-D, PHQ-9, BDI o equivalente), en el criterio principal definido por cada ensayo; Cuando se reportan múltiples puntos temporales, la jerarquía predefinida será el punto final principal definido por el ensayo y luego el punto temporal más cercano a las 6 semanas posteriores a la dosis. Cuando los ensayos reportan la misma escala, se agruparán diferencias medias (DM); en diferentes escalas se utilizarán diferencias medias estandarizadas (g de setos), ambas con intervalos de confianza del 95% según modelos de efectos aleatorios (REML). Se prefieren escalas valoradas por el clínico frente a la auto-reporte cuando un ensayo reporte ambos.

Resultado coprimario: cambio respecto al punto base en la gravedad de los síntomas de ansiedad en escalas validadas (HAM-A, GAD-7, STAI, BAI o equivalente), con la misma jerarquía de puntos temporales y medidas de efecto.

Los puntos de tiempo también se agruparán para el análisis de sensibilidad como agudos (hasta 2 semanas), a corto plazo (3 a 8 semanas) y sostenidos (12 semanas o más) tras la dosis.

Resultados adicionales

Respuesta: proporción de participantes que logran al menos un 50% de reducción respecto al inicio en la gravedad de los síntomas depresivos (o de ansiedad) en la escala primaria, en el criterio principal definido por el ensayo. Remisión: proporción por debajo del umbral específico establecido de la escala (por ejemplo, MADRS ≤ 10 , HAM-D ≤ 7 , GAD-7 y 5). Ambos se sintetizarán como razones de riesgo (RR) con intervalos de confianza del 95% a partir de modelos de efectos aleatorios; Se reportarán diferencias de riesgo cuando los efectos absolutos ayuden a la interpretación.

Funcionamiento y calidad de vida: cambio respecto a la línea base en instrumentos validados (por ejemplo, SDS, WSAS, WHOQOL-BREF, SF-36, EQ-5D), sintetizados como MD o Hedges' g siguiendo las mismas reglas que los resultados principales.

Seguridad: proporción de participantes con cualquier evento adverso, eventos adversos graves y eventos adversos de especial interés (ideación o comportamiento suicida emergente del tratamiento; alteraciones perceptivas prolongadas; episodios hipertensivos agudos), sintetizados como RR donde el recuento de eventos lo permite, y resumidos de forma descriptiva con conteos exactos por brazo. Manejo de cero eventos: se describirán pruebas sin eventos en ninguno de los dos brazos pero no se agruparán; las correcciones de continuidad no se aplicarán por defecto, y se realizará un análisis de sensibilidad con el método Mantel-Haenszel sin corrección para eventos raros.

SÍNTESIS DE DATOS PLANIFICADA

Estrategia para la síntesis de datos

Se realizará un metaanálisis de efectos aleatorios para cada resultado con al menos dos comparaciones que contribuyan, utilizando la estimación REML de la varianza entre estudios con el ajuste de Hartung-Knapp-Sidak-Jonkman para intervalos de confianza. Medidas de efecto: MD (misma escala) o g de Hedges (escalas diferentes) para resultados continuos; RR para resultados dicotómicos. La heterogeneidad se cuantificará con I^2 , τ^2 y la Q de Cochran, y se reportarán intervalos de predicción del 95% para todas las estimaciones agrupadas. Los ensayos multibrazo contribuirán con la comparación primaria pre-especificada (comparador mínimo activo); Si se incluyen dos brazos del mismo ensayo en un análisis, el grupo de control compartido se dividirá para evitar el doble conteo. Los ensayos cruzados aportarán datos del primer periodo. Análisis de moderadores predefinidos (análisis de subgrupos o meta-regresión de efectos aleatorios según corresponda, realizados cuando hay al menos 10 comparaciones disponibles): régimen de dosis, presencia de psicoterapia asistida, población diagnóstica (trastorno depresivo frente a trastorno de ansiedad), tipo de comparador. Análisis de sensibilidad predefinidos: exclusión de ensayos con alto riesgo de sesgo; exclusión de preprints; agrupación por puntos temporales (aguda, a corto plazo, posdosis sostenida); Análisis de dejar uno fuera. Cualquier análisis post-hoc se etiquetará explícitamente como tal. Los análisis se realizarán en R (metafor y metapackages); Los scripts de análisis y los conjuntos de datos derivados se publicarán en el repositorio público del proyecto. Si la síntesis cuantitativa no es factible para un resultado (menos de dos comparaciones o heterogeneidad clínica o metodológica extrema), los resultados se informarán narrativamente siguiendo las directrices de SWIM (Síntesis Sin Metaanálisis), con tablas estructuradas y gráficos de dirección de efectos.

MÉTODOS DE REVISIÓN EN VIDA

Métodos vivos de revisión sistemática

No hay vista previa disponible

FASE ACTUAL DE REVISIÓN

Fase de la revisión en esta presentación

Fase de revisión	Empezó	Completado
Trabajo piloto	✓	
Búsqueda formal/identificación de estudios		
Filtrar los resultados de la búsqueda en función de los criterios de inclusión		
Extracción de datos o recepción de IPD		
Riesgo de sesgo/evaluación de la calidad		
Síntesis de datos		

Estado de la revisión

La revisión está actualmente prevista o en curso.

Publicación de los resultados de la revisión

Los resultados de la revisión se publicarán en inglés.

REVISIÓN DE AFILIACIÓN, FINANCIACIÓN Y REVISIÓN POR PARES

Miembros del equipo de revisión

Profesor Miguel Ángel Trejo-Rodríguez (aval de revisión y contacto) ORCID: 0000-0001-8251-6665. UNAM. México.

No se declaró ningún conflicto de intereses.

Profesor Erik González-Ballesteros. UNAM. México.

No se declaró ningún conflicto de intereses.

Dra. Sandra Martínez-Robles. UNAM. México.

No se declaró ningún conflicto de intereses.

Señorita Andrea Estefanía Aranda Rosas. UNAM. México.

No se declaró ningún conflicto de intereses.

El señor Leandro Jesús Lozano García. UNAM. México.

No se declaró ningún conflicto de intereses.

Contacto nombrado

Profesor Miguel Ángel Trejo-Rodríguez (farma_matr@cuautitlan.unam.mx). ORCID: 0000-0001-8251-6665. UNAM. México.

Afiliación a la reseña

Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Universidad Nacional Autónoma de México

Fuente de financiación

La revisión no cuenta con financiación específica o externa, pero está apoyada por instituciones del equipo de aval o revisión (no comercial).

Información adicional sobre la financiación

Sin financiación externa ni específica. La revisión cuenta con el apoyo de la institución académica de los autores (UNAM) mediante el tiempo académico protegido y el acceso institucional de las bibliotecas a los textos completos.

Revisión por pares

No ha habido ninguna revisión por pares de esta revisión planificada.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional

Esta revisión es el brazo metaanalítico de un estudio híbrido cuyo brazo bibliométrico paralelo ha sido completado y publicado, junto con el protocolo completo, en <https://doi.org/10.5281/zenodo.21893380> (GitHub: psilocybin-bibliometrics-2026). El depósito incluye el protocolo PRISMA-P/PRISMA-S, todas las estrategias de búsqueda, la cadena de deduplicación tri-base de datos, el corpus bibliométrico derivado (n = 1.921 documentos únicos, 2022-2026), tablas descriptivas y figuras. El brazo bibliométrico mapea la estructura y el crecimiento del campo y no extrae datos de resultados clínicos; No se había iniciado ningún cribado, extracción ni síntesis de la presente revisión en el momento de este registro. Los scripts de análisis, conjuntos de datos de extracción, evaluaciones de riesgo de sesgo y tablas GRADE de esta revisión se publicarán en el mismo repositorio público al finalizar. Las enmiendas al protocolo se versionarán en el repositorio y se reflejarán en la pista de auditoría de este registro.

Revisión del conflicto de intereses

Los intereses individuales declarados se registran bajo los datos de los miembros del equipo... No se registran intereses adicionales para esta revisión.

Encabezamientos de Temas Médicos

Adulto; Alcoholismo; Ansiedad; Trastornos de ansiedad; Clasificación; Demencia; Depresión; Trastorno Depresivo Mayor; Alimentación y trastornos alimentarios; Humanos; Neoplasias; enfermedad de Parkinson; Psilocibina; Psicoterapia; Calidad de vida; Ensayos controlados aleatorizados como tema

Historia de la versión de PROSPERO

No hay vista previa disponible

Aviso legal

El contenido de este registro muestra la información proporcionada por el equipo de revisión. PROSPERO no revisa los registros de registro por pares ni respalda su contenido.

PROSPERO acepta y publica la información proporcionada de buena fe; La responsabilidad del contenido de los registros recae en el equipo de revisión. El garante de este expediente ha afirmado que la información proporcionada es veraz, y que entiende que la provisión deliberada de información inexacta puede interpretarse como mala conducta científica.

PROSPERO no asume ninguna responsabilidad por el contenido proporcionado en este registro ni por su uso. Los lectores utilizan la información proporcionada en este registro bajo su propio riesgo.

Cualquier consulta sobre el registro debe remitirse al contacto de revisión designado